HBV・HCV 報告支援システムの構築と業務効率化への取り組み

◎小林 彩夏[1)]、久野 敬子[1)]、廣田 優美[1)]、堀江 史織[1)]
社会医療法人 宏潤会 大同病院[1)]

【はじめに】肝炎ウイルスは、症状のないまま肝硬変や肝がんへ移行する場合もあり、HBV・HCV 陽性患者への適切な受診推奨及び経過管理が重要である。当院では、HBs 抗原または HCV 抗体陽性患者に対し、検査技師が前歴確認、医師への連絡及び受診状況の追跡を行っている。年間では、HBs 抗原陽性 247 件、HCV 抗体陽性 174 件（2024 年 3 月～2025 年 2 月）であった。一連の報告業務は、Excel を用いた陽性患者リストに手入力し管理していたため、業務負担の増大や確認漏れが課題であった。

そこで今回、当院検査技師が独自に HBV・HCV 報告支援システムを構築したので、その取り組みについて報告する。

【方法】Microsoft Access を用いて、報告支援システムを構築した。検査日と患者 ID を入力することで、電子カルテ情報から結果、過去の陽性歴及び DNA 定量検査値を自動抽出した。また、患者カルテより病名登録歴や治療薬使用歴、該当の記載を抽出し、前歴の有無や報告の要否を判定できる機能を実装した。さらに、確認者の入力欄及び受診推奨状況の管理機能を設けた。後追いについては、検査日以降の消化器内科受診または予約状況を抽出し精査の有無を確認できる仕組み、精査未確認患者リストを設けた。

【結果】システム導入により、カルテ記載や過去検査値の確認作業が自動化され、陽性患者の抽出から報告までの業務が技師間で統一化された。また、後追い管理に必要な情報が一覧化され、確認漏れの防止が可能となった。

【考察】HBs 抗原及び HCV 抗体陽性報告が統一化されたことで、従来の手作業による確認業務が大幅に削減され、業務効率の向上が得られた。また、カルテ記載の見落としが最小化され、ヒューマンエラー発生リスク低下も期待される。これにより、肝炎ウイルス陽性患者拾い上げ及び対応の検査技師主体での運用が容易となる可能性が示唆された。

【結語】今回のシステム導入は、報告精度の向上及び検査技師間の業務統一化に寄与したと言える。この結果を受け、今後は他の感染症項目についてもシステム構築を目指していきたい。

連絡先：052-611-6261（内線：7214）